

GUÍA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

Administración de medicamentos por vía oral, sublingual y rectal

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TSEN	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Taller de administración de medicamentos por vía oral, SL y rectal
SEMESTRE	2° SEMESTRE	N° ACTIVIDAD	1
ASIGNATURA	EBS 2111	DURACIÓN	80 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
1. Demostrar técnica de administración de fármacos por vía oral, sublingual y rectal, en una situación simulada. 2. Aplicar normas y protocolos para la administración segura de fármacos de acuerdo con el rol del TENS.			

3: INTRODUCCIÓN

La administración de medicamentos por vía enteral es un procedimiento propio del rol del técnico superior de enfermería, como parte del proceso terapéutico en los distintos niveles y sistemas de atención de salud, por lo que debe existir un acabado conocimiento respecto de los fundamentos de farmacología y las normas y protocolos relacionados para ejecutar de forma segura esta técnica. La vía enteral, considera la cavidad oral, que corresponde a la administración del medicamento en la boca para que pueda ser deglutido, la vía sublingual, que corresponde a la administración del medicamento depositándolo debajo de la lengua para que sea disuelto, participando en este proceso, la humedad y la temperatura de la zona sublingual y por último la vía rectal, que consiste en la administración del medicamento en la zona rectal.

En el caso de pacientes que requieren la introducción del medicamento por vía digestiva alta y carecen de reflejo de deglución, se considera la administración mediante una sonda digestiva, que puede ser nasogástrica o nasoyeyunal.

En esta guía encontrará el contenido necesario para el aprendizaje de la administración de las vía oral, sublingual y rectal.

4: DESARROLLO DEL TEMA

VIA ORAL: se considera la entrada al tubo digestivo, por lo tanto, esta vía se utiliza para que el medicamento llegue a la cavidad gástrica gracias a la deglución. Su administración se considera una técnica de mínima dificultad, la que puede ser utilizada en pacientes con un tubo digestivo funcional y un nivel de lucidez que les permita deglutir de forma segura. Por esta vía, se debe considerar que pueden existir interacciones entre el fármaco y algunos alimentos, por lo que es fundamental conocerlas y además de identificar el tipo de alimento, se debe considerar el horario de ingestión de éstos, en la planificación de enfermería respecto de la administración del medicamento. Esta vía, a pesar de su alta efectividad, está contraindicada en pacientes con alteración de su estado de conciencia, pacientes con alteración del tubo digestivo de tipo estructural y funcional como, por ejemplo, en el caso de



estados de náuseas, vómitos o algunas patologías que generen disfunción a algún nivel.

VÍA SUBLINGUAL: es considerada una vía especial ya que a este nivel existe una rica vascularización, lo que permite que el fármaco administrado por esta vía, después de ser disuelto en la saliva, inicia su proceso de farmacocinética, ingresando a través de la extensa red de vasos venosos y linfáticos de la mucosa sublingual y del tejido conjuntivo submucoso llegando posteriormente a la vena cava superior.

La presentación farmacéutica de los medicamentos sublinguales corresponde a tabletas, películas, obleas o aerosoles.

Entre sus principales ventajas se reconoce:

- Fácil de administración.
- Tener velocidad de absorción y biodisponibilidad superior a la vía oral.
- Inicio de acción más rápido, en comparación con los fármacos ingeridos por la vía oral, al permitir el tránsito directo del principio activo a la circulación sistémica.
- Por su rápido efecto, es especialmente útil en situaciones de urgencia (coronariopatía, hipertensión arterial, etc.).
- Evita una posible alteración o inactivación gastrointestinal o hepática.
- El efecto del medicamento puede suspenderse rápidamente, por ejemplo, escupiendo la tableta.

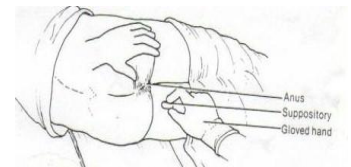


Entre las limitaciones se identifica:

- Solo se pueden administrar sustancias dosificables en pequeña cantidad (pocos miligramos) al ser limitada la superficie bucal.
- Las variaciones del pH bucal (entre 6,7 y 7) pueden alterar la absorción
- Alteran la absorción que el paciente haya fumado una hora antes de administrar el medicamento o haya ingerido café en el mismo tiempo.
- Si el medicamento se traga, puede causar irritación gástrica.

VÍA RECTAL: corresponde a la porción terminal del tubo digestivo, tiene una capa serosa peritoneal, una túnica muscular, una capa submucosa y una capa o túnica mucosa.

La absorción del fármaco se realiza a nivel local, lo cual evita en parte el efecto de paso por el hígado, antes de incorporarse a la circulación sistémica. Las formas de administración rectal se usan para conseguir efectos locales. El fármaco se introduce en el organismo directamente (supositorios) o con la ayuda de algún mecanismo (enemas y sonda rectal, por ejemplo).



Son contraindicaciones generales para la administración de cualquiera enema:

- Pacientes con patología anorrectal (hemorroides, fisuras, abscesos...)
- Intervención quirúrgica muy reciente en la zona perineal o abdominal
- Pacientes cardíacos, ya que existe el riesgo de la estimulación del nervio vago.
- Sospecha de apendicitis, peritonitis o cualquier tipo de patología a nivel abdominal.

PROTOCOLO BASE DE ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS:

De acuerdo con la OMS, la recomendación para la administración de medicamentos, en el contexto del cuidado y protección de la seguridad del paciente, se establece mediante la aplicación del Protocolo de administración segura de medicamentos, que implica:

1) Verificar: Paciente correcto:

- Nombre completo del usuario (2 nombres y 2 apellidos)
- Identificación del paciente como Rut, número de ficha o ID
- Chequea brazalete
- Consulta Alergia (medicamentos y alimentos)

2) Verifica indicación en ficha clínica. Medicamento

- Nombre del medicamento, dosis, vía de administración, frecuencia horaria, nombre y firma del médico

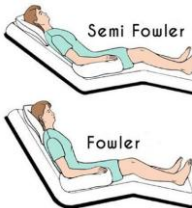
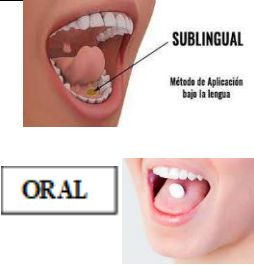
Los 10 correctos en la administración de medicamentos son:

1. Medicamento
2. Paciente
3. Dosis
4. Vía de administración
5. Hora
6. Fecha de caducidad o vencimiento
7. Antecedente de alergia
8. Preparar y administrar un mismo profesional
9. Registro
10. Observar respuesta

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

- Descripción de administración de medicamentos por **vía oral y sublingual**

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar lavado clínico de manos según norma ministerial		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Revisar indicación médica y correctos para la administración de fármaco.		El médico es el profesional responsable de la indicación de la farmacología que se le debe administrar al paciente. Con la indicación debe revisar los correctos para la administración del fármaco.
3. Preparar los materiales necesarios para la administración del medicamento		Debe preparar su bandeja con: la orden médica, el medicamento, guantes, vaso, agua, bajalengua (SOS), toalla de papel.

4. Presentarse con nombre y cargo al paciente		Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende.
5. Verificar el paciente correcto: en ficha clínica, preguntándole y revisando brazalete.		Uno de los cuidados fundamentales para la administración de medicamentos es la verificación de los correctos.
6. Informar el procedimiento y aclarar dudas		Es un derecho del paciente conocer las terapias y tratamientos que se le administrarán.
7. Acomodar al paciente en posición fowler o semi fowler		Mejora la respiración al permitir una mejor expansión pulmonar lo que facilita la ventilación y la oxigenación.
8. Consultar al paciente y corrobora en ficha posible alergia al fármaco.		Medida de seguridad para prevenir reacciones adversas.
9. Utilizar guantes de procedimiento		Si el paciente tiene alguna limitación cognitiva o motora, el TSEN deberá introducir el medicamento a la boca, por lo que debe aplicar medida de protección al contacto con fluido
10. Introducir el medicamento en la cavidad oral (sobre la lengua) o sublingual (bajo la lengua), según la indicación médica.		Dependiendo de la autonomía del paciente, le puede entregar el medicamento o lo debe introducir directamente a la cavidad oral o sublingual
11. Observar la reacción o respuesta del paciente		Hay que considerar que la vía sublingual es una vía de absorción rápida que se utiliza en algunas situaciones de urgencia, por lo que debe estar atento a la reacción del paciente al fármaco.
12. Ordenar materiales y eliminar desechos según normativa REAS		Cualquier procedimiento de enfermería debe culminar con el orden de la unidad del paciente,

		la eliminación y orden de los materiales.
13. Deja cómodo al paciente.		Cuidado humanizado y personalizado.
14. Realizar higiene de manos según normativa ministerial.		Después de atender al paciente se debe realizar higiene de manos como medida de prevención de IAAS.
15. Registrar del procedimiento completo. (Nombre del paciente, fecha, hora, medicamento, dosis, vía, responsable)		El registro es la evidencia escrita de la técnica realizada y debe contener en él los correctos verificados, la reacción del paciente y cualquier incidente relacionado con la técnica.

- Descripción de administración de medicamentos por vía rectal

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar lavado clínico de manos según norma ministerial		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Revisar la indicación médica en ficha clínica		El médico es el profesional responsable de la indicación de la farmacología que se le debe administrar al paciente. Con la indicación debe revisar los correctos para la administración del fármaco.
3. Preparar los materiales necesarios para la administración del medicamento		Debe preparar su bandeja con: la orden médica, el medicamento, guantes, pechera, lubricante, enema o medicamento, toalla de papel.
4. Presentarse con nombre y cargo al paciente		Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende.
5. Verificar el paciente correcto: en ficha clínica, preguntándole y revisando brazalete.		Uno de los cuidados fundamentales para la administración de medicamentos es la verificación de los correctos

6. Informar el procedimiento y aclarar dudas		Es un derecho del paciente conocer las terapias y tratamientos que se le administrarán.
7. Consultar al paciente y corroborar en ficha posible alergia al fármaco.		Medida de seguridad para prevenir reacciones adversas.
8. Ubicar biombo y hacer cama partida para proteger la privacidad del paciente		Uno de los principios para la atención del paciente es el respeto por su privacidad.
9. Usar guante de procedimiento y pechera.		La introducción de medicamento por la vía rectal, involucra riesgo de contacto con materia orgánica, por lo que se debe aplicar protocolo de bioseguridad con el uso de EPP.
10. Verificar las condiciones del paciente y lo posiciona en Sims izquierdo		La posición lateral hacia el lado izquierdo, por anatomía favorece la introducción del medicamento en la vía rectal.
11. Lubricar el introductor del enema o sonda si corresponde		La lubricación del extremo del introductor o de cualquier elemento rígido, favorece el contacto con la mucosa, protegiéndola y genera menos molestias al paciente.
12. Introducir el fármaco o enema indicando al paciente que lo retenga.		La introducción del medicamento en el recto puede estimular en el paciente la eliminación del mismo, por lo que debe voluntariamente tratar de retenerlo para no eliminarlo.
13. Observar la reacción o respuesta del paciente		Hay que considerar que en la vía rectal el medicamento actúa a nivel local y se absorbe directamente. Considerar también el riesgo de la estimulación vagal.
14. Ordenar materiales y eliminar desechos según normativa REAS		Cualquier procedimiento de enfermería debe culminar con el orden de la unidad del paciente, la eliminación y orden de los materiales.

15. Dejar cómodo al paciente.		Cuidado humanizado y personalizado.
16. Realizar higiene de manos según normativa ministerial.		Después de atender al paciente se debe realizar higiene de manos como medida de prevención de IAAS.
17. Realizar registro del procedimiento completo. (Nombre del paciente, fecha, hora, medicamento, dosis, vía, responsable)		El registro es la evidencia escrita de la técnica realizada y debe contener en él los correctos verificados, la reacción del paciente y cualquier incidente relacionado con la técnica.

6. PAUTA DE COTEJO

Pauta de cotejo de Administración de medicamentos por vía oral y/o sublingual

Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos según norma		
2. Se Presenta con nombre y cargo al paciente		
3. Verifica indicación médica de administración de fármaco		
4. Verifica paciente: nombre, brazaletes de identificación y alergias <u>antes de preparar el medicamento (Pausa de seguridad 1)</u>		
5. Prepara los materiales necesarios para la administración del medicamento		
6. Verifica los correctos del medicamento indicado		
7. Verifica el paciente correcto: Orden médica, nombre, brazaletes de identificación y alergias <u>antes de administrar el medicamento (Pausa de seguridad 2)</u>		
8. Informa al paciente el procedimiento a realizar		
9. Verifica las condiciones del paciente (posición semisentada, nivel de autonomía, ingestión de alimento previo, alergias)		
10. Utiliza guantes de procedimiento		
11. Administra el medicamento: SL: Ubica el medicamento bajo la lengua según dosis indicada (usa bajalengua SOS) ORAL: entrega el medicamento o lo pone sobre la lengua y menciona que debe verificar que el paciente se lo trague (usa bajalengua SOS)		
12. Observa la reacción o respuesta del paciente en busca de efectos secundarios o adversos		
13. Ordena materiales, elimina desechos de acuerdo con norma REAS.		
14. Deja cómodo al paciente.		
15. Se lava las manos según normativa ministerial.		
16. Registra completo del procedimiento. (Nombre del paciente, fecha, hora, medicamento, dosis, vía, responsable)		

Pauta de cotejo de administración de medicamentos por vía rectal.

Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos según norma		
2. Se Presenta con nombre y cargo al paciente		
3. Verifica indicación médica de administración de fármaco		
4. Verifica paciente: nombre, brazalete de identificación y alergias <u>antes de preparar el medicamento (Pausa de seguridad 1)</u>		
5. Prepara los materiales necesarios para la administración del medicamento		
6. Verifica los correctos del medicamento indicado		
7. Verifica el paciente correcto: Orden médica, nombre, brazalete de identificación y alergias <u>antes de administrar el medicamento (Pausa de seguridad 2)</u>		
8. Informa al paciente el procedimiento a realizar		
9. Ubica biombo y realiza cama partida para proteger la privacidad del paciente		
10. Utiliza guantes de procedimiento y pechera.		
11. Verifica las condiciones del paciente y lo posiciona en Sims izquierdo		
12. Lubrica el introductor del enema o sonda si corresponde		
13. Introduce el fármaco o enema indicando al paciente que lo retenga.		
14. Observa la reacción o respuesta del paciente en busca de efectos secundarios o adversos		
15. Ordena materiales, elimina desechos de acuerdo con norma REAS.		
16. Deja cómodo al paciente.		
17. Se lava las manos según normativa ministerial.		
18. Registra del procedimiento completo. (Nombre del paciente, fecha, hora, medicamento, dosis, vía, responsable)		

7: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Díaz P, Fabeiro MJ, González C, Méndez L, Muiños D, Novoa AI, López C, Pardo I. <i>Procedimiento de administración de medicación por vía sublingual</i>. 2021. 2. Basanta A, Castro MM, Jiménez LR, Martínez A, Pérez MT, Vázquez A. <i>Procedimiento de administración de medicación por vía rectal</i>. 2022. 3. Organización Mundial de la Salud. Marco para los servicios de salud integrados centrados en las personas [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019
--